（四）不稳定型心绞痛 VS 稳定型心绞痛

	稳定型心绞痛	不稳定型心绞痛
病理基础	①稳定斑块致**固定显著**狭窄 ②无显著狭窄者可能是冠脉痉挛等	①不稳定斑块**破裂等继发血栓形成、栓塞、冠脉痉挛**等 ②变异型：冠脉自发严重痉挛
心肌缺血	需氧增加型	供氧减少型（主要）和需氧增加型 不稳定斑块破裂后继发血栓形成会加重冠脉阻塞
胸痛表现	明显诱因，多持续 3-5 分钟 休息/含服硝酸甘油缓解	可有诱因也可休息时发生，多持续 10-30 分钟 冠脉的狭窄不固定**发作频率高（1 个月来反复出现）** 不会超过30分钟，超过30分钟考虑心肌梗死
休息或硝酸甘油	易缓解 不能通过看含服硝酸甘油后症状好不好转判断是稳定型心绞痛还是不稳定型心绞痛	暂时或不能完全缓解
发作变数	**数个月内无明显变化**　看本质:斑块是否稳定	数个月内可明显变化
发作时心电图	暂时性 ST 段压低≥0.1mv	①暂时性 ST 段压低≥0.1mv ②**变异型：暂时性 ST 段抬高** 心肌透壁缺血损伤
PCI	规范用药后无效可行 PCI	①**最佳治疗。极高危者 2 小时内行 PCI** ②**变异型：首选硝苯地平、不用 β-R 拮抗剂**
抗板	阿司匹林或吲哚布芬（抑制 COX-1）。 支架植入加替格瑞洛或氯吡格雷（拮抗 P_2Y_{12}/血小板 ADP 受体）	**阿司匹林或吲哚布芬+替格瑞洛或氯吡格雷双联抗血小板＞1 年。PCI 术中追加替罗非班或阿昔单抗（拮抗血小板 GPIIb/IIIa 受体）**
抗凝	不需常规抗凝	**抗板基础上常规抗凝**

四、急性非 ST 段抬高型心肌梗死

（一）NSTEMI VS 不稳定型心绞痛

临床表现:看胸痛时间
实验室检查:看心肌坏死标志物

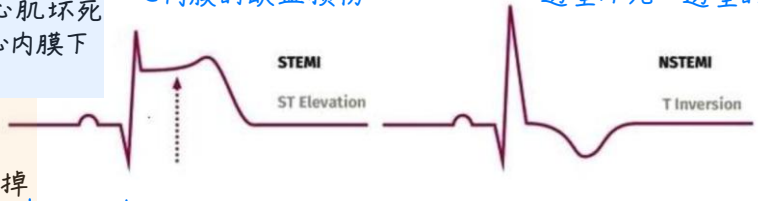
不稳定型心绞痛	NSTEMI
治疗基本类似	
胸痛多＜30 分钟	胸痛**数小时**
心肌坏死标志物多正常	**心肌坏死标志物↑**
心电图改变可随症状缓解部分或完全消失（暂时性改变）	心电图改变多＞12 小时

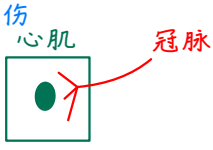
（二）NSTEMI VS STEMI

	NSTEMI	STEMI
尽管住院期间死亡率 NSTEMI 低于 STEMI、但它们长期心血管事件发生率接近		
多支血管病变率	高、侧枝循环多	低
冠脉闭塞程度	非完全	完全
冠脉内的血栓	以血小板为主的白色血栓	以纤维素为主的混合血栓或红色血栓
溶栓	**禁止溶栓**	无禁忌症可行溶栓
心肌坏死标志物	透壁全层坏死　升高没有 STEMI 明显 心内膜下	透壁/全层 明显增高 冠脉完全闭塞
典型心电图	病理 Q 多无、ST 段压低≥0.1mv、T 波倒置	**病理 Q、ST 段弓背向上抬高、T 波倒置**

心绞痛没有病理Q,因为没有心肌坏死
NSTEMI没有病理Q,因为是心内膜下的坏死

抗板:抗血小板聚集
抗凝:防止纤维蛋白形成
溶栓:将已形成的纤维蛋白溶掉





		稳定型心绞痛	不稳定型心绞痛	NSTEMI	STEMI(冠脉完全闭塞)
(冠脉完全闭塞)变异型心绞痛					
√	缺血	√	√	√	√
全层透壁 √	损伤	√ 心内膜	√ 心内膜	√ 心内膜	√ 全层透壁
	坏死			√ 心内膜	√ 全层透壁
↑	ST	↓	↓	↓	↑
	病理Q				√